HOSPITAL GENERAL DE CASTELLON

Servicio de RADIOLOGIA

| | |
|---|---|
| Centro peticionario<br>Centre peticionari | HOSPITAL GENERAL DE CASTELLON |
| Sección peticionaria<br>Secció peticionaria | URGENCIAS GENERALES |
| Médico peticionario<br>Metge peticionari | |
| Diagnóstico<br>Diagnòstic | sospecha TEP |
| Situación<br>Situació | |
| Cama<br>Llit | |

NHC

SIP

Núm. de informe
*Núm. d'informe*

| | |
|---|---|
| Primer apellido<br>Primer cognom | |
| Segundo apellido<br>Segon cognom | |
| Nombre<br>Nom | |
| Fecha de nacimiento<br>Data de naixement | |
| Sexo<br>Sexe | Mujer |

# Informe de prueba diagnóstica / Informe de prova diagnòstica

## Datos clínicos / Dades clíniques

Mujer de 86 años que acude por sensación disneica, fatiga que aumenta al caminar desde hoy por la tarde, al usar su propio puloximetro se encuentra SpO2 82%. No refiere fiebre termometrado en su casa.
Analiticamente no presenta elevación de RFA.
FG 53,85 ml/min/sup
dimero-D 2.583,00 ng/mL

## Exploraciones informadas / Exploracions informades

19/07/2025 23:54 TC VASCULAR ARTERIAS PULMONARES, Capturado por: (ENFERMERA)

## Valoración / Valoració

Datos clínicos:
Mujer de 86 años que acude por sensación disneica, fatiga que aumenta al caminar desde hoy por la tarde, al usar su propio puloximetro se encuentra SpO2 82%. No refiere fiebre termometrado en su casa.
Analiticamente no presenta elevación de RFA.
FG 53,85 ml/min/sup
dimero-D 2.583,00 ng/mL
SOSPECHA TEP.

Técnica: Angio-TC de arterias pulmonares con contraste intravenoso.
Se compara con estudios previos.
Estudio parcialmente artefactado por los movimientos respiratorios de la paciente durante su adquisición.

Hallazgos:
Se identifican defectos de repleción en arteria lobar de lóbulo inferior derecho así como en ramas segmentarias de lóbulo superior e inferior izquierdo compatibles con tromboembolismo pulmonar.
Atelectasias laminares en ambos campos pulmonares.
No se identifica reflujo de contraste a vena cava superior como signo de sobrecarga derecha. Cono de la arteria pulmonar de 25 mm.

No derrame pleural. Elevación del hemidiafragma derecho ya conocido.

Valoración / Valoració

Bocio endotorácico izquierdo.
Atrofia renal derecha.
Sin otros hallazgos a reseñar respecto estudios previos.

Anexos:

Autores / Autors

Fdo./Signat QUEROL RIPOLL, ROSER

RADIOLOGO RESPONSABLE

20/07/2025